

ANGINE - Cours de Microbiologie

Université : **UNIVERSITE D'ALGER**

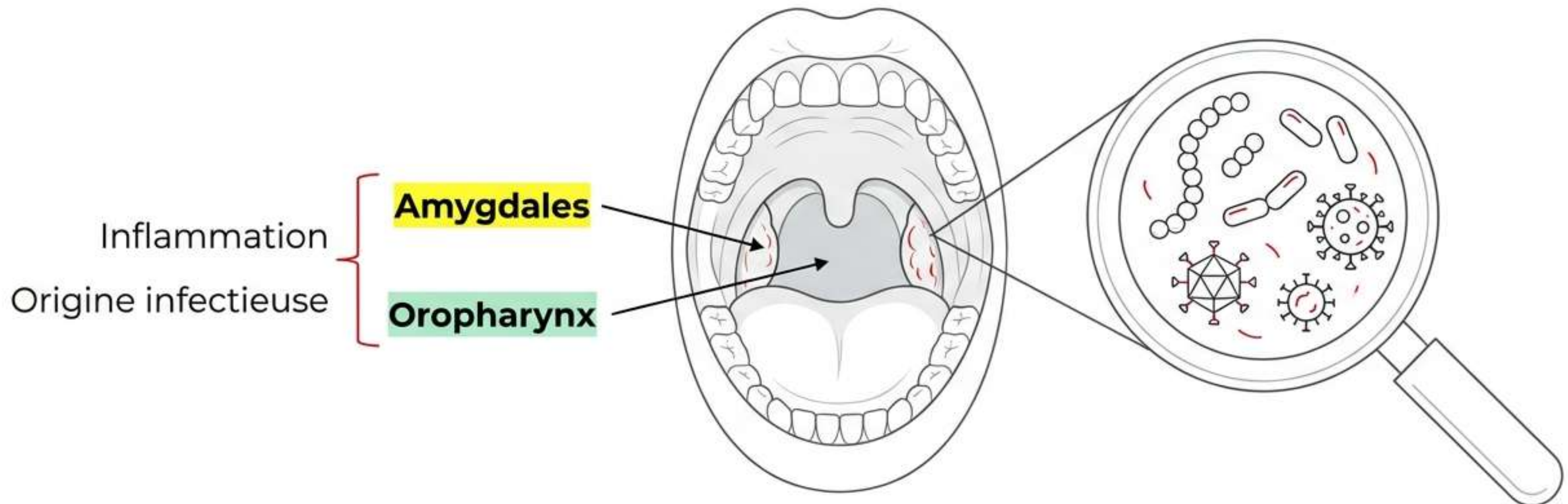
Faculté : **FACULTE DE MEDECINE**

Enseignement : **ENSEIGNEMENT DE MICROBIOLOGIE**

Niveau : **2EME ANNEE DE CHIRURGIE DENTAIRE**

Année Universitaire : **2022/2023**

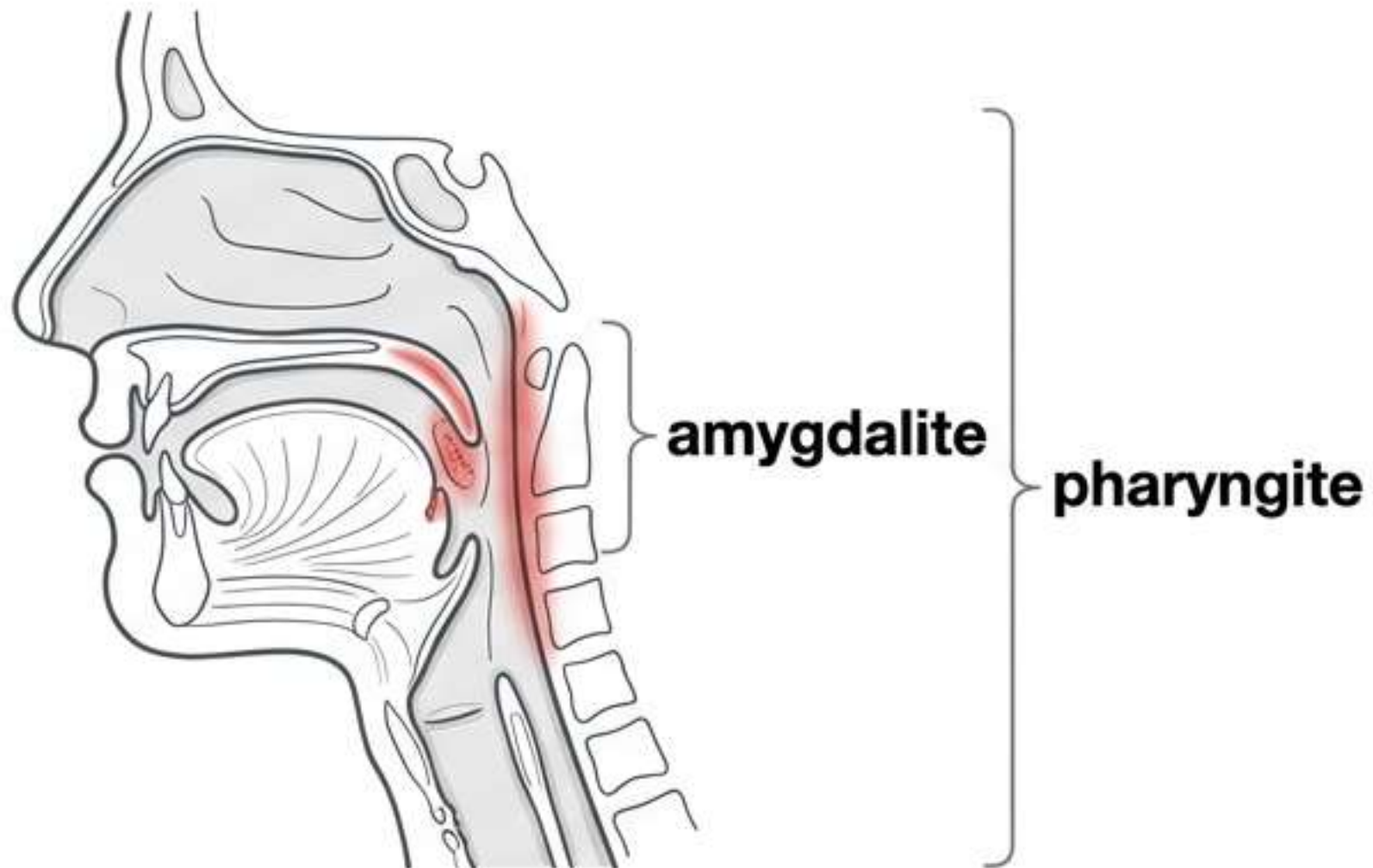
Enseignant : **Dr HENNICHE**



Définition et Épidémiologie

Définition anatomique : Inflammation d'origine infectieuse des :

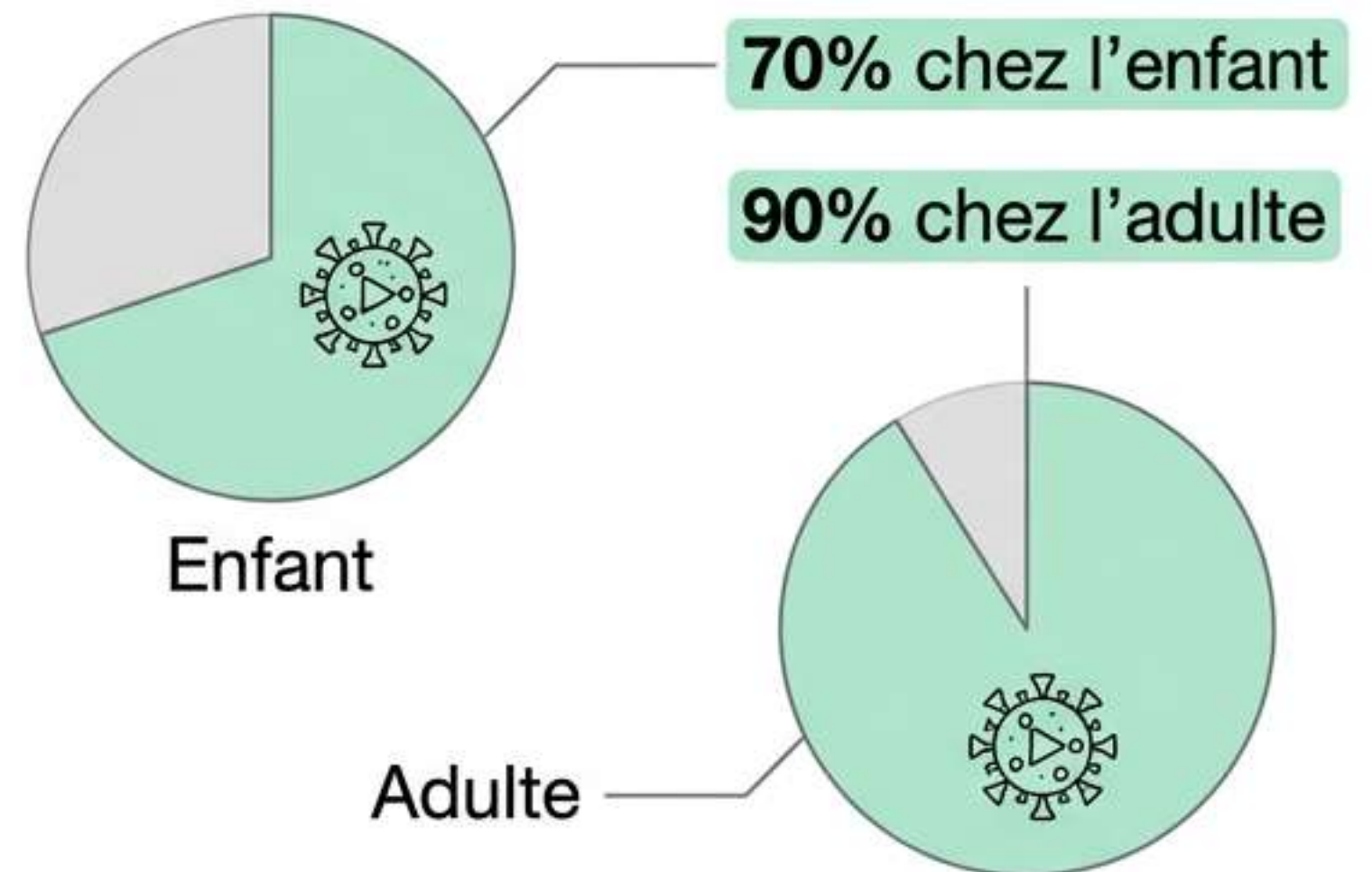
- Amygdales (amygdalite) et / ou
- L'ensemble de l'oropharynx (pharyngite).



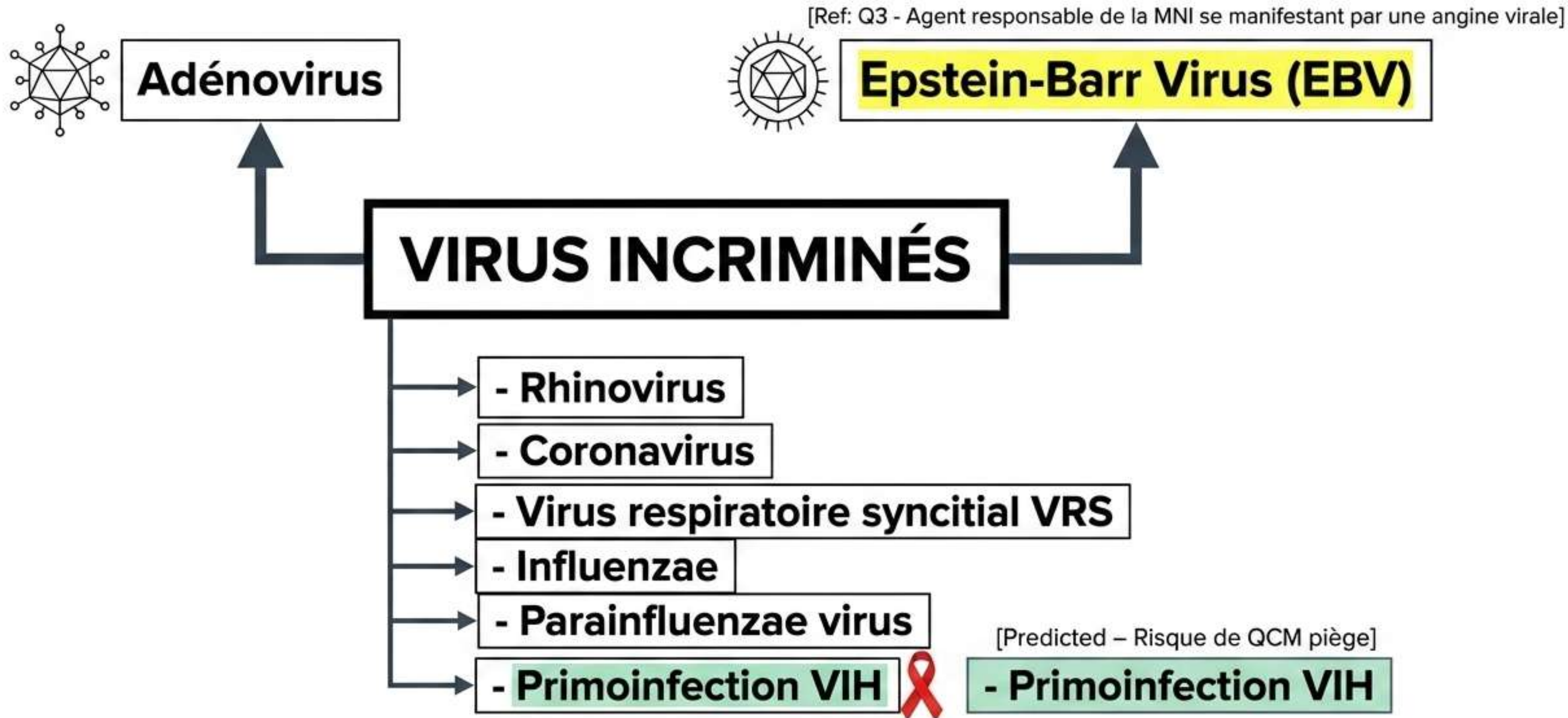
Consultation : Motif médical très fréquent, surtout chez l'enfant.

Évolution : Spontanément favorable.

Origine majoritaire (Virale) :

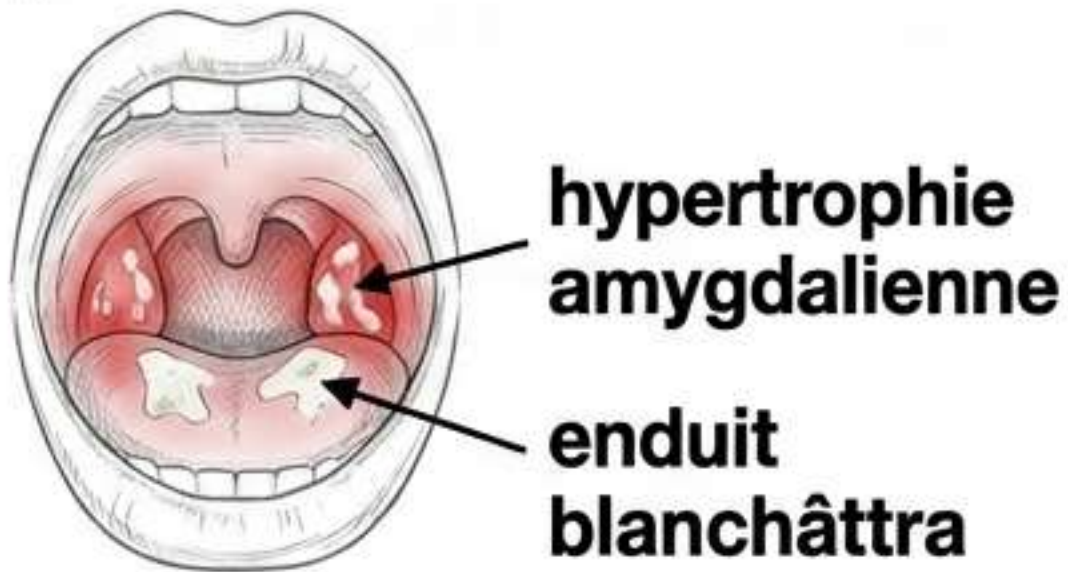


Étiologies Microbiennes : Angines Virales



Angine Érythématopultacée (Bactérienne) - Bactériologie & Clinique

Signes Cliniques



Signes Cliniques Locaux :

- Hypertrophie amygdalienne.
- Inflammation pharyngée.
- Parfois présence d'un enduit blanchâtre recouvrant les amygdales.

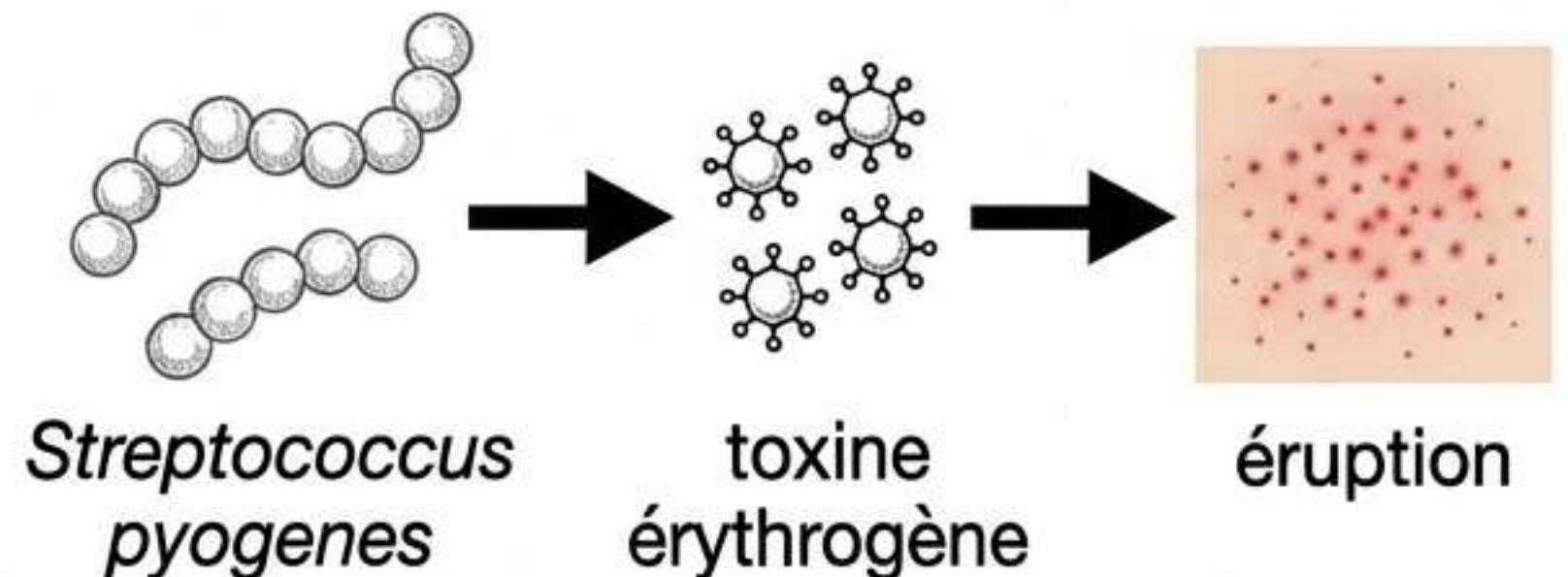
Signes Cliniques Généraux :

- Fièvre, dysphagie, otalgies, tuméfaction cervicale.

Bactériologie & Mécanisme

Agent Pathogène : *Streptococcus pyogenes* (streptocoque β -hémolytique du groupe A).

Mécanisme toxinique : Sécréteur de toxine érythrogène responsable de l'éruption.

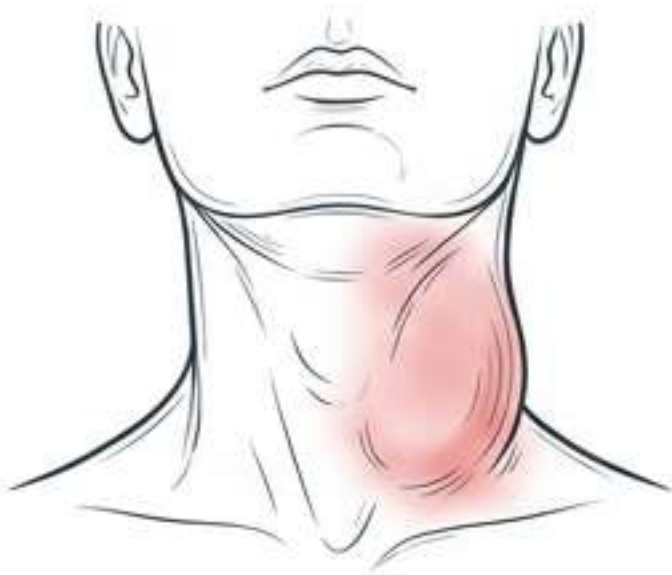


Angine Érythématopultacée : Les Complications

Complications Streptococcus pyogenes

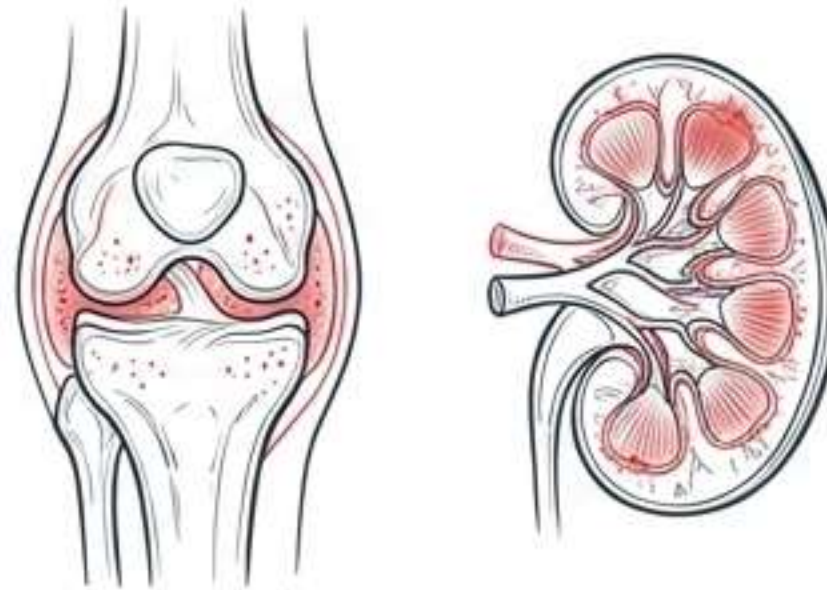
1. Complications Locales

(accentuation de la symptomatologie locale et générale)



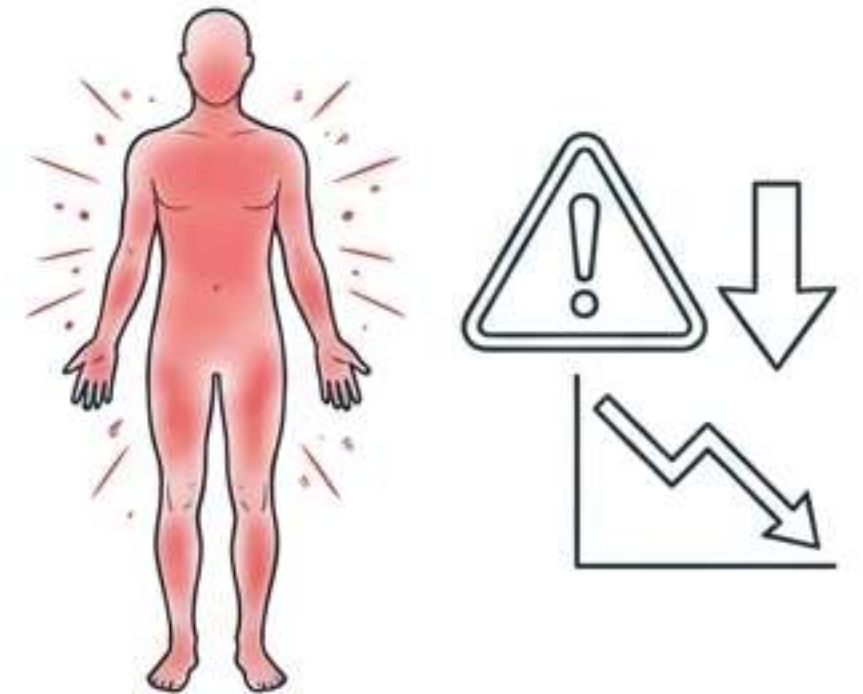
- Phlégmon périamygdalien.
- Adénophlégmon.
- Cellulite cervicale.

2. Complications Immunologiques post streptococciques



- Rhumatisme articulaire aigue (RAA)
- La glomérulonéphrite aigue (GNA)

3. Complications Toxiniques



- Scarlatine.
- Le choc toxique streptococcique.

Angine Diphtérique

(pseudomembraneuse ou à fausse membrane)

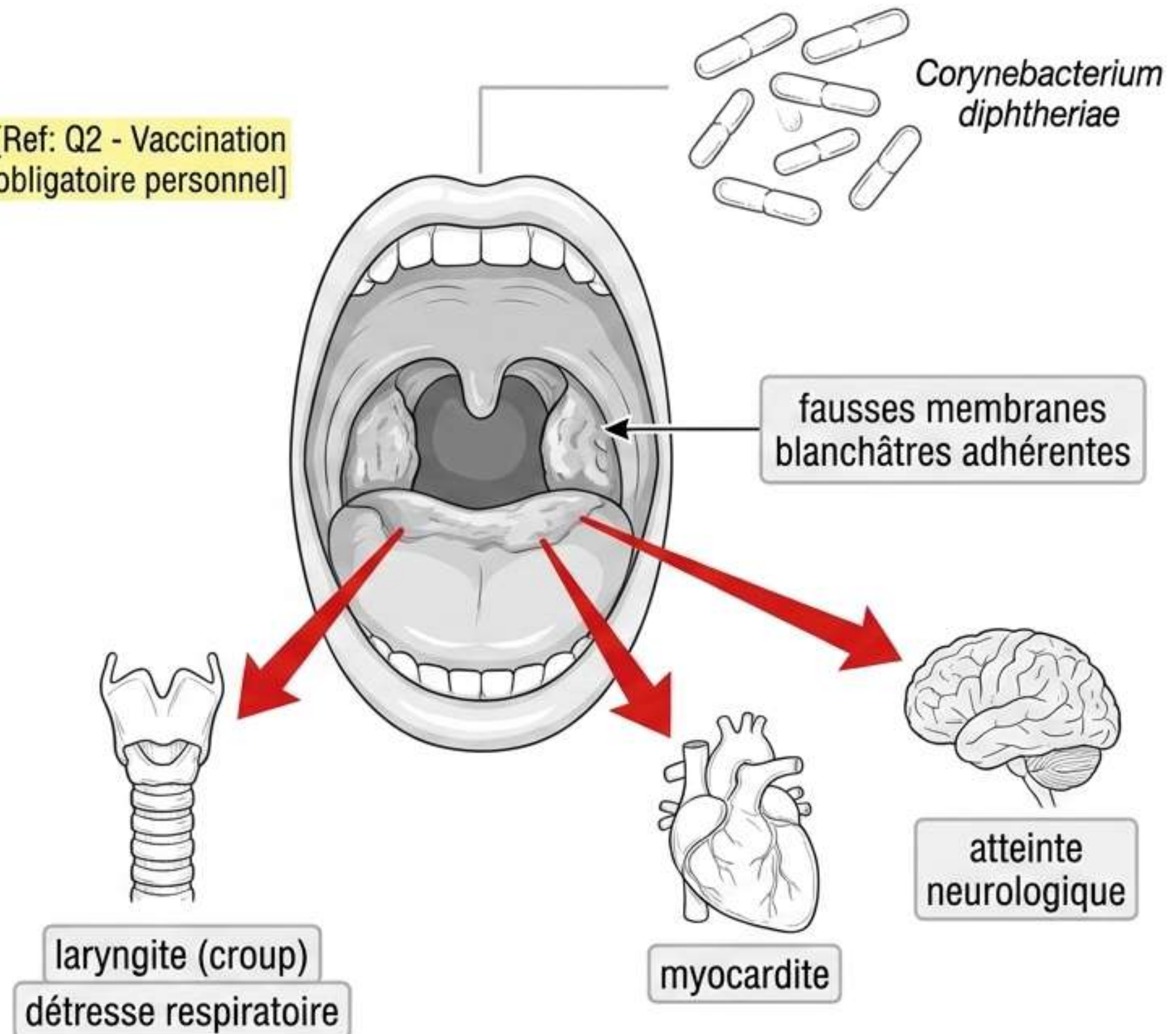
Gravité : Maladie grave.

Agent Pathogène : Due au *Corynebacterium diphtheriae* seule espèce pathogène. Les autres espèces du genre *Corynebacterium* sont commensales de la peau et des muqueuses de l'homme.

[Ref: Q2 - Vaccination obligatoire personnel]

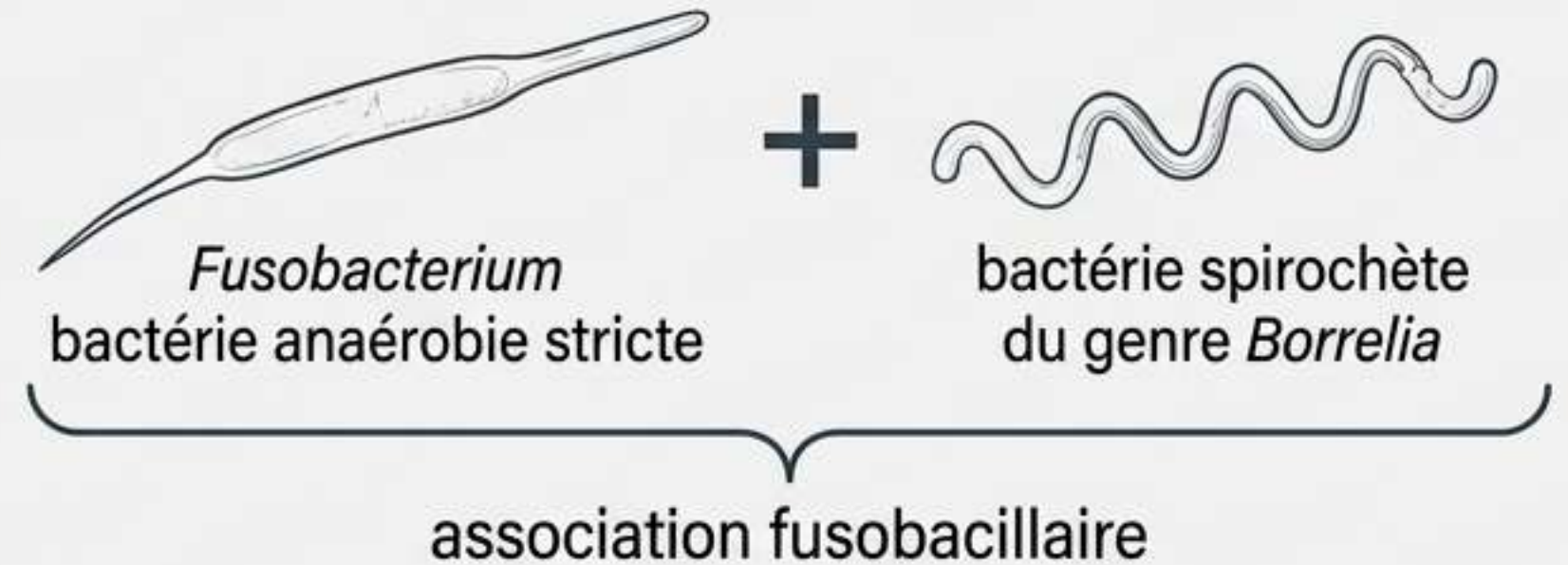
Signes Cliniques :

- Fièvre.
- Angine avec fausses membranes blanchâtres adhérentes recouvrant les amygdales.
- Adénopathies cervicales.



Angine Ulcéronécrotique ou Angine de Vincent

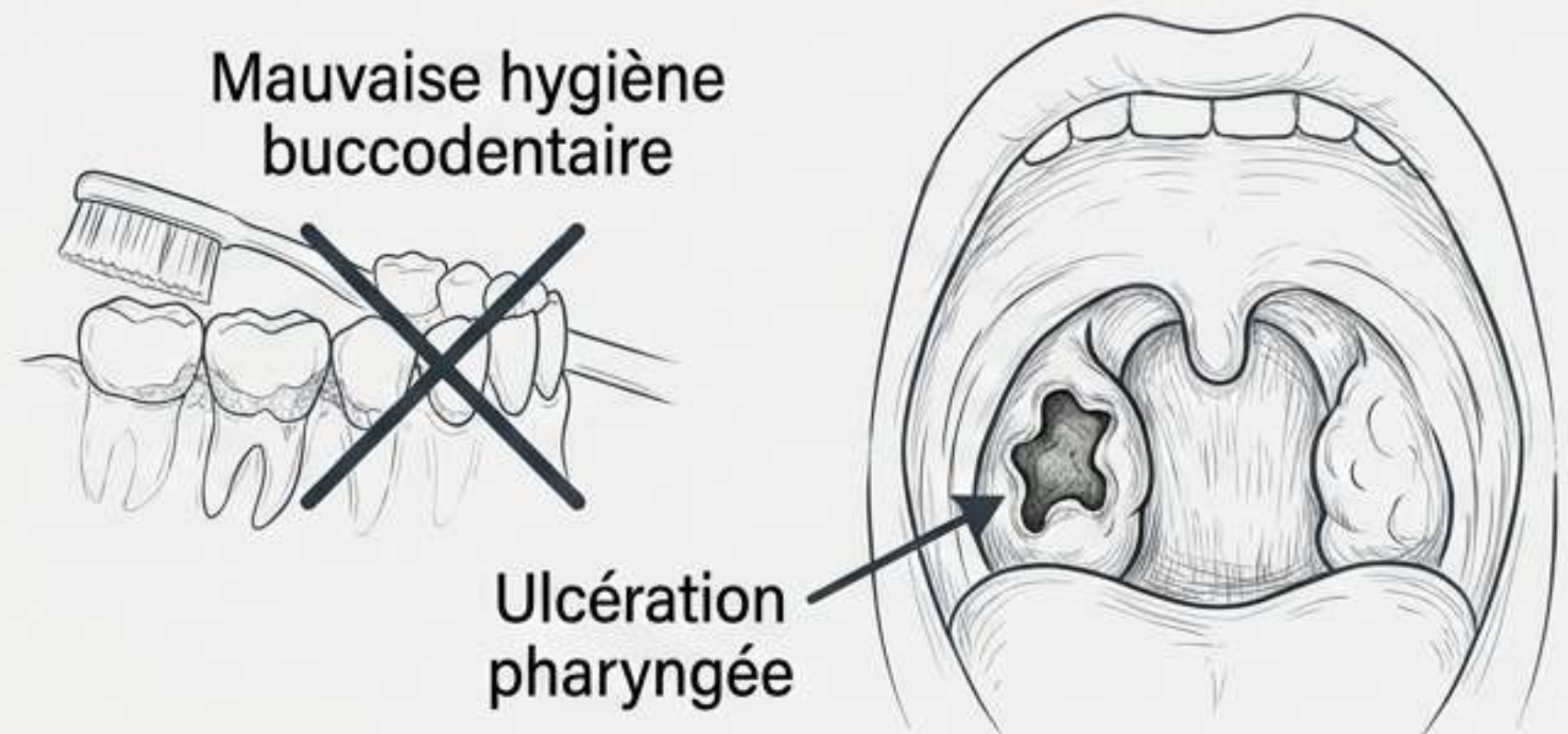
Étiologie (Association fusobacillaire) :
Association entre *Fusobacterium* bactérie anaérobie stricte et une bactérie spirochète du genre *Borrelia*. [Ref: Q1]



Facteurs de risque : Mauvaise hygiène buccodentaire.

Signes Cliniques :

- Mauvaise haleine.
- Ulcération pharyngée.



Diagnostic et Protocole de Prélèvement

Nature du diagnostic : Le diagnostic est clinique.

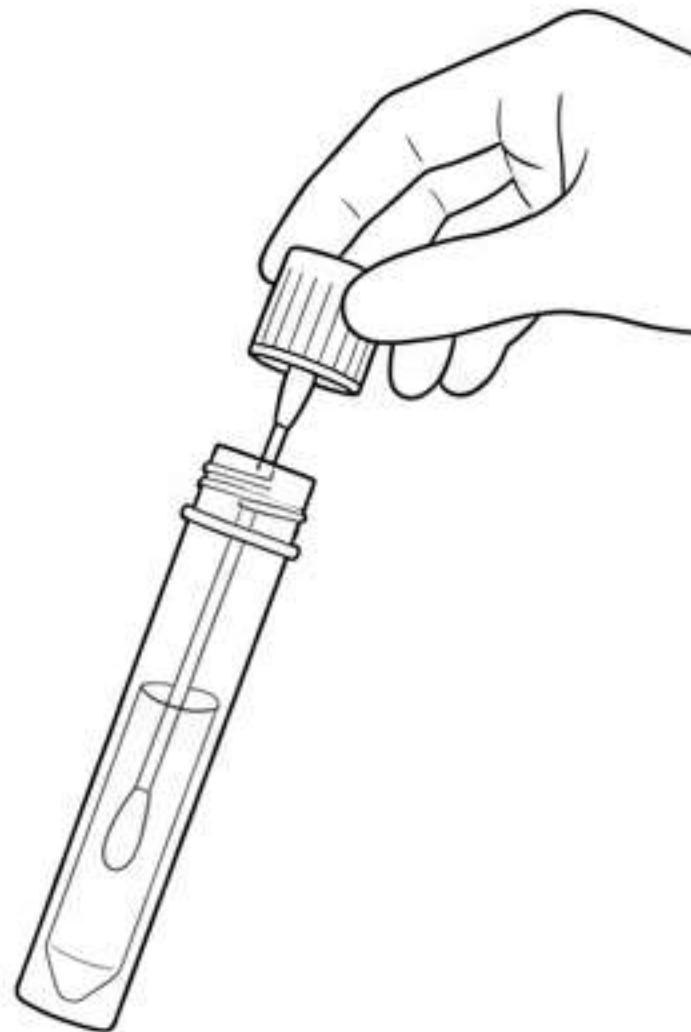
Objectif du prélèvement : Un prélèvement de gorge servira pour l'étude bactériologique afin de préciser l'agent causal.

Step 1

Technique stricte : L'utilisation d'un abaisse-langue est nécessaire pour éviter la contamination par la flore oropharyngée. Le prélèvement est fait par écouvillonnage des amygdales.



Step 2



Step 3

Acheminement : Les écouvillons sont acheminés rapidement au laboratoire. Accompagnés d'une fiche de renseignements.



acheminés
rapidement

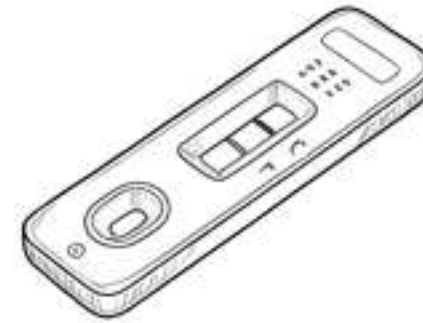


fiche de
renseignements

Les Tests de Diagnostic au Laboratoire

Selon l'agent pathogène suspecté, le laboratoire utilise des tests spécifiques :

Pour le **Streptocoque β -hémolytique du groupe A**



Test de diagnostic rapide (TDR) de détection.

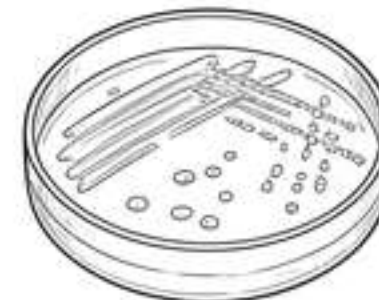
Pour l'**Angine de Vincent**



Examen direct

[Predicted – Diagnostiqué visuellement, sans culture]

Pour la **Diphtérie**



La culture.

Traitement Symptomatique & Angine Virale

À FAIRE



Traitement symptomatique de base :

- Antipyrétiques.
- Antalgiques (paracétamol).



INTERDIT

Contre-indications absolues :
Pas de corticoides ni AINS



Prise en charge de l'Angine virale :

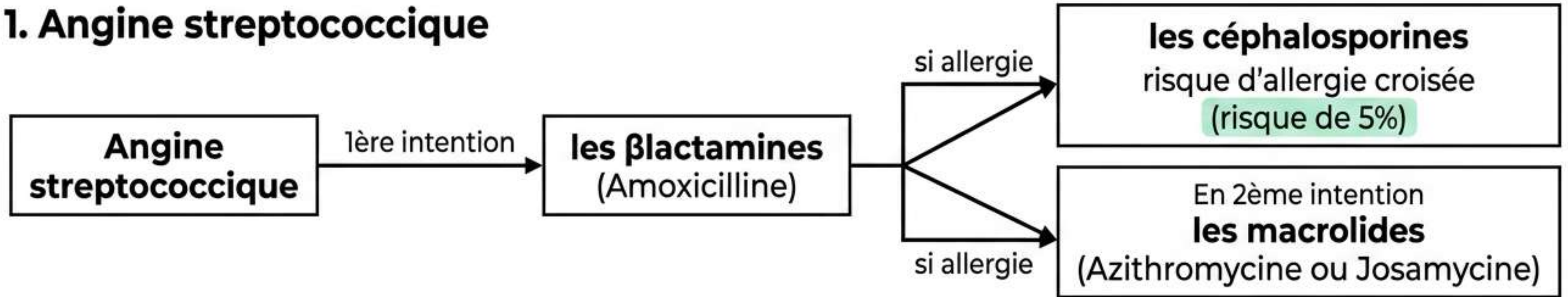
- Pas de traitement antibiotique.
- Traitement symptomatique uniquement.



Angine virale : pas de
traitement antibiotique

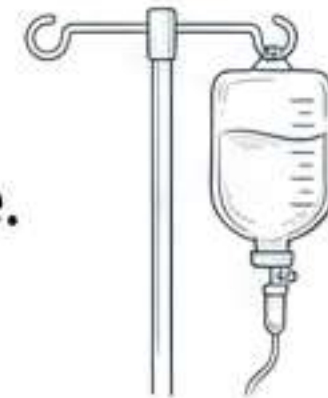
Traitements Antibiotiques Spécifiques (Bactériennes)

1. Angine streptococcique



2. Diphtérie

Association pénicilline G et sérothérapie.

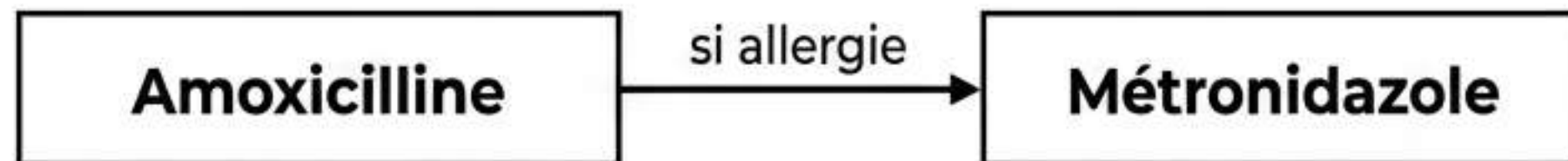


sérothérapie



pénicilline G

3. Angine de Vincent



Prévoir une consultation dentaire.

Synthèse Différentielle : Les 3 Angines Bactériennes

Type d'Angine	Agent Pathogène	Signes Cliniques	Test Labo	Complications
Érythématopultacée	Streptococcus pyogenes (groupe A)	Enduit blanchâtres, éruption	TDR	RAA, GNA,  locales, toxiques.
Diphtérique	Corynebacterium diphtheriae	Fausse membranes blanchâtres adhérentes	Culture	Croup, détresse respiratoire, myocardite,  neurologique.
De Vincent	Fusobacillaire (Fusobacterium + Borrelia)	Ulcération, mauvaise haleine, mauvaise hygiène 	Examen direct	(Nécrose locale)

Exam Pattern Analysis

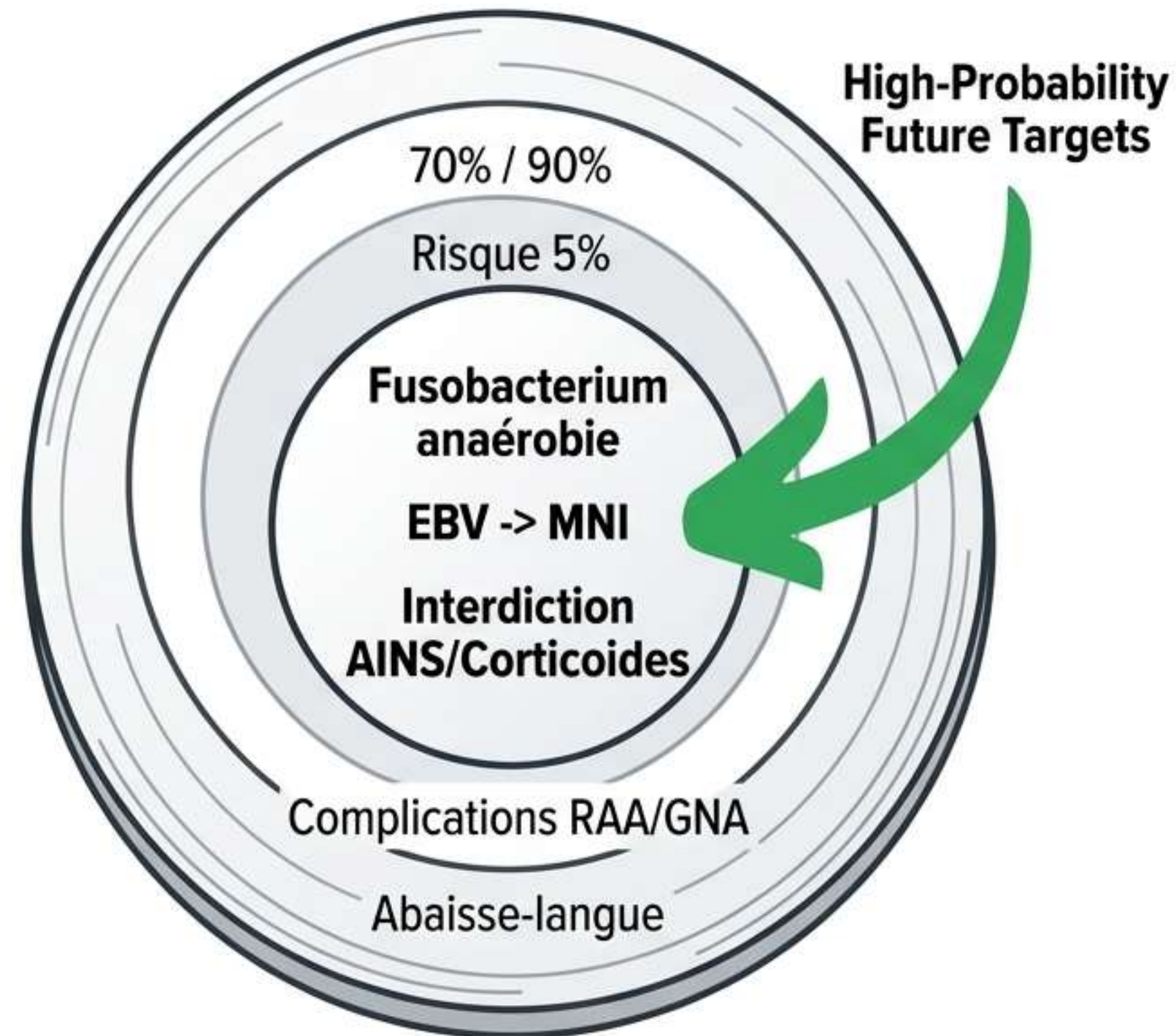
Sujets les plus répétés (Past Exams) :

- **Caractéristiques physiologiques** : Fusobacterium en anaérobie stricte (Q1-2018).
- **Rôle des agents viraux majeurs** : EBV agent de MNI se manifestant par angine virale (Q3-2018).
- **Prévention médicale** : Vaccination diphtérie obligatoire pour le personnel (Q2-2022).

Nombres et Pièges (Predictions) :

Zones à haut risque futur :

- **Le piège mortel** : Prescrire corticoïdes ou AINS (Interdiction absolue).
- **Les chiffres clés** : 70% (enfant) / 90% (adulte) d'origine virale ; 5% d'allergie croisée céphalosporines.
- Détails des complications post-streptococciques (RAA, GNA) et le protocole de prélèvement (utilisation obligatoire de l'abaisse-langue pour éviter la flore).



Cartographie Mentale Finale

